

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

EIDA · ESCALA DE LA INTENSIDAD DE LA DEPENDENCIA DEL ALCOHOL

Adaptación Española del Severity of Alcohol Dependence Questionnaire (SADQ) – Evaluación de dependencia física y neurobiológica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Escala de la Intensidad de la Dependencia del Alcohol (EIDA)
Autores Originales	Adaptación española del SADQ (Stockwell et al., 1979; Edwards & Gross, 1976)
Autores Validación	Helena Rodríguez-Martos et al. (1986); Gabriel Rubio, B. Urosa y J. Santo Domingo (1998)
Tipo de Instrumento	Autoinforme o cuestionario heteroaplicado clínico estructurado
Población Diana	Pacientes adultos diagnosticados de Trastorno por Uso de Alcohol (TUA)
Tiempo de Aplicación	8 a 12 minutos (30 reactivos clínicos)
Formato de Respuesta	Escala tipo Likert de 4 opciones: Casi nunca (0), A veces (1), A menudo (2), Casi siempre (3)
Finalidad Clínica	Cuantificación de la gravedad de la dependencia física, predicción del riesgo de síndrome de abstinencia grave (delirium tremens) y selección del ámbito de desintoxicación (ambulatorio vs hospitalario)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La EIDA se fundamenta operativamente en el célebre “Síndrome de Dependencia del Alcohol” postulado por Griffith Edwards y Milton Gross en 1976 para la Organización Mundial de la Salud. Dicho modelo establece que la dependencia alcohólica es una dimensión psicobiológica diferenciada de los problemas sociales o consecuencias médicas secundarias asociadas al consumo excesivo.

El constructo nuclear reside en la neuroadaptación del sistema nervioso central al etanol: tolerancia farmacológica celular, aparición estereotipada de síntomas físicos y afectivos de abstinencia tras unas horas sin beber, alivio inmediato mediante el consumo matutino suplementario (“alivio de abstinencia”) y la rápida reinstauración del patrón de dependencia biológica tras períodos prolongados de abstinencia. La EIDA evalúa un período típico de consumo severo reciente del paciente para cuantificar con rigor esta neuroadaptación.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Sección / Subescala	Nº Ítems	Manifestaciones Sintomáticas Evaluadas
1. Síntomas Físicos Abstinencia	6 ítems	Sudoración matutina, temblor de manos/cuerpo, náuseas y taquicardia.
2. Síntomas Afectivos Abstinencia	6 ítems	Ansiedad matutina, ánimo disfórico, irritabilidad y pánico ante la falta de alcohol.
3. Conducta de Alivio	6 ítems	Necesidad compulsiva de beber por la mañana para frenar el temblor y funcionar.
4. Consumo Típico Diario	6 ítems	Velocidad de ingesta, cantidad de alcohol ingerido y prioridad sobre otras tareas.
5. Reinstauración tras Recaída	6 ítems	Rapidez en reaparecer los síntomas físicos tras reiniciar el consumo tras abstinencia.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · EIDA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad interna (Alfa de Cronbach global = 0.93 en Rodríguez-Martos et al., 1986, y 0.95 en Rubio et al., 1998). Subescalas: entre 0.82 y 0.91.
Validez Predictiva	Predice con elevada exactitud la gravedad del síndrome de abstinencia alcohólica (sensibilidad 91% para delirium tremens y crisis comiciales en pacientes con EIDA > 35).
Validez Concurrente	Correlación sobresaliente con el SADQ original ($r = 0.96$), con marcadores biológicos hepáticos (GGT, $r = 0.62$; VCM, $r = 0.54$) y con el MAST ($r = 0.76$).
Invarianza Clínica	Propiedades psicométricas replicadas en centros de desintoxicación hospitalaria y unidades ambulatorias de alcoholismo de toda España.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Puntuación de Ítems:** Cada uno de los 30 reactivos se puntúa de 0 a 3:
 - Casi nunca = 0 puntos
 - A veces = 1 punto
 - A menudo = 2 puntos
 - Casi siempre = 3 puntos
- Puntuación Total:** Suma de los 30 ítems evaluados.
- Rango de Puntuación:** De 0 a 90 puntos totales.
- Marco Temporal de Referencia:** El evaluador instruye al paciente a responder basándose en el período de mayor consumo de los últimos 6 meses.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación EIDA	Nivel de Dependencia	Riesgo Abstinencia	Ámbito Terapéutico y Manejo Médico
0 a 15 puntos	Dependencia Leve	Muy Bajo (< 5%)	Desintoxicación ambulatoria simple o reducción guiada.
16 a 30 puntos	Dependencia Moderada	Moderado (20-30%)	Desintoxicación ambulatoria estructurada con benzodiazepinas.
31 a 50 puntos	Dependencia Grave	Alto (> 60%)	Desintoxicación hospitalaria o ambulatoria intensiva supervisada.
51 a 90 puntos	Dependencia Muy Grave	Crítico (> 85%)	Ingreso hospitalario urgente; alto riesgo de Delirium Tremens.

CRITERIO CLÍNICO DE DERIVACIÓN HOSPITALARIA (EIDA > 30): Una puntuación superior a 30 puntos indica neuroadaptación profunda. El cese brusco del consumo sin cobertura farmacológica sedante (diazepam o clometiazol) conlleva un riesgo inaceptable de convulsiones tónico-clónicas por privación y cuadro confusional grave.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · EIDA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Aplicación Previa a la Desintoxicación: Cumplimentar antes de retirar la ingesta alcohólica.

Paso 2: Elección del Régimen Asistencial:

- **Si EIDA ≤ 15:** Desintoxicación en régimen ambulatorio en centro de salud; soporte vitamínico oral (Tiamina B1 300 mg/día) y seguimiento a 48 horas.
- **Si EIDA 16-30:** Desintoxicación ambulatoria en Centro de Atención a las Drogodependencias (CAD); pauta descendente de diazepam (10 mg cada 6-8 h) y supervisión por un familiar responsable.
- **Si EIDA > 30:** Derivación a Unidad Hospitalaria de Desintoxicación (UHD) por riesgo biológico vital, especialmente si coexisten antecedentes de delirium, hepatopatía o cardiopatía.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 49 años, obrero de la construcción, traído a la consulta de adicciones por su hermano tras presentar temblores intensos en las manos todas las mañanas que sólo calman al beber dos copas de aguardiente.

Evaluación Psicométrica Inicial: EIDA Total = 44 / 90 puntos (Dependencia Grave, Alto Riesgo de Abstinencia).

- **Síntomas Físicos:** 15 / 18 puntos. Náuseas matutinas y sudoración profusa generalizada.
- **Conducta de Alivio:** 14 / 18 puntos. Bebe sistemáticamente en ayunas antes de salir de su domicilio para poder afeitarse y caminar sin temblor.
- **Consumo Diario:** 10 / 18 puntos. Consumo estimado de 14 UBEs diarias (140 g de alcohol puro).

Manejo Terapéutico: Dada la puntuación en la EIDA (> 30) y el antecedente de una convulsión previa en una tentativa de cese por cuenta propia, se desaconsejó la desintoxicación ambulatoria y se coordinó el ingreso en la Unidad Hospitalaria de Desintoxicación. Recibió cobertura con pauta descendente de diazepam y tiamina parenteral, cursando sin convulsiones ni delirium tremens. Tras el alta, inició tratamiento de deshabituación con acamprosato y psicoterapia cognitivo-conductual grupal de prevención de recaídas.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

EMERGENCIAS MÉDICAS EN ABSTINENCIA

- La encefalopatía de Wernicke debe prevenirse con tiamina intramuscular o intravenosa antes de administrar soluciones glucosadas.
- El Delirium Tremens tiene una mortalidad de hasta el 5% sin monitorización estricta; vigilar fiebre, alucinaciones zóopsicas y taquicardia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Consumo Perjudicial sin Dependencia:** Problemas legales o familiares por borracheras ocasionales sin neuroadaptación física matutina.
- **Tremor Esencial / Parkinsonismo:** El temblor esencial mejora con alcohol pero no asocia sudoración, náuseas ni craving.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Rodríguez-Martos, A., Navarro, R. M., & Vecino, C. (1986). Validación preliminar de la adaptación española de la Escala de Intensidad de la Dependencia del Alcohol (EIDA). *Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona*, 13(4), 187–195.
- Rubio, G., Urosa, B., & Santo Domingo, J. (1998). Validación de la escala de la intensidad de la dependencia al alcohol. *Psiquiatría Biológica*, 5(Supl 1), 44–47.
- Stockwell, T., Hodgson, R., Edwards, G., Taylor, C., & Rankin, H. (1979). The development of a questionnaire to measure severity of alcohol dependence. *British Journal of Addiction*, 74(1), 79–87.
- Edwards, G., & Gross, M. M. (1976). Alcohol dependence: Provisional description of a clinical syndrome. *British Medical Journal*, 1(6017), 1058–1061.